Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana
Dipartimento economia aziendale, sanità e sociale

SUPSI

Il Paradigma della Qualità di vita e il Progetto di Vita

Chiara Balerna, Michela Luraschi, Donatella Oggier-Fusi, Piercarla Reposo,
Percorsi nella disabilità 2026

Obiettivi:

- Fare il punto sui riferimenti concettuali che accompagnano il lavoro educativo con le persone con disabilità

- Conoscere il Meta modello della Qualità di Vita,
  i fattori, i domini e gli indicatori

- Riflettere attorno agli strumenti per progettare la QdV:
  il Progetto di Vita e i PEI/PSI

- Sperimentarsi con uno strumento di valutazione multidimensionale basato sul Modello della QdV

I punti di riferimento teorici, metodologici ed etici

- La Classificazione ICF dell'OMS e l'approccio bio-psico-sociale
- La Convenzione Onu per i Diritti delle persone con Disabilità
- L'evoluzione delle forme istituzionali: in cammino verso l'inclusione
- La co-progettazione educativa, i metodi dialogici e il sistema dei sostegni
- La prospettiva della Qualità di vita e il Progetto di Vita

Il cambio di sguardo: dall'approccio medico a quello bio-psico-sociale- L'ICF

Sguardi e linguaggi medico-individualisti abilisti

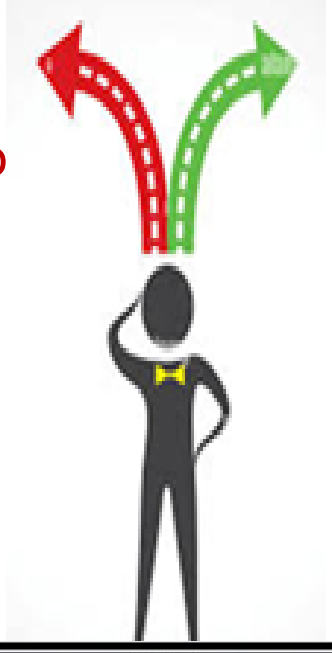
La persona è la sua diagnosi e il suo deficit – affidamento agli specialisti
non ci sono potenziali di sviluppo – il futuro statico e standardizzato -
Il ruolo operatore: prescrittore (*devi fare così!*)
Priorità: protezione dai rischi, assistenza individuale, postura paternalistica

Sguardi e linguaggi bio-psico-sociali (ICF)

Diversità come modo originale di relazionarsi – tutti hanno potenziali di sviluppo - futuro dinamico – rimozione degli ostacoli - **rete di sostegni**
ruolo operatore: consigliere (*cosa vorresti fare?*), accompagnare **all'autonomia per la realizzazione personale**, accettare il rischio dell'indipendenza- lavorare sui contesti-Modello ecologico

Dalla cura della persona alla cura dei contesti, la persona con disabilità protagonista della propria vita

Dipendenza	**Autonomia**
Eterno bambino	**Adultità**
Malattia- Diagnosi	**Funzionamento-sostegni**
Esclusione	**Partecipazione**
Emarginazione	**Inclusione**
Bisogni	**Diritti e desideri**
Deficit individuali	**Contesti- barriere**



Il Paradigma della Qualità di vita

laRegione, lunedì 20 marzo 2023 LA RUBRICA 22

EDUCAZIONE

La qualità di vita nella disabilità

L'autonomia è essenziale per aumentare la qualità di vita

BENDER-HOTZ

Molti fattori influenzano la qualità di vita delle persone con disabilità intellettiva. Le prestazioni socio-educative svolgono un ruolo centrale.

di Elisa Geronimi, Centro competenze bisogni educativi, scuola e società (BESS), DFA-SUPSI

Il concetto di qualità di vita riguarda tutte le persone, eppure esso non è sempre stato applicato a quelle con disabilità intellettiva. In effetti, è solo da pochi decenni – grazie in particolare a leggi e dichiarazioni internazionali (come quelle dell'ONU), al movimento di desistituzionalizzazione e al concetto di normalizzazione – che è aumentato l'interesse per la qualità di vita delle persone con disabilità intellettiva.

Qualità di vita e fattori che la influenzano

Quello di qualità di vita non è un concetto di facile definizione, soprattutto perché interessa molte dimensioni. Il modello di riferimento a livello internazionale in questo ambito (quello di Schalock e Verdugo) mette in evidenza otto domini che compongono la qualità di vita: sviluppo personale; autodeterminazione; relazioni interpersonali; inclusione sociale; diritti; benessere emotivo; benessere fisico; benessere materiale. La qualità di vita può essere influenzata, positivamente o negativamente, tanto da fattori personali (quanto ambientali.

La letteratura internazionale ha messo in evidenza vivere in un contesto comunitario (per esempio con la famiglia). Tra i fattori personali, l'età ha in generale un impatto sulla qualità di vita (con il suo aumento la qualità di vita tende a peggiorare). Anche il livello di disabilità intellettiva esercita un'influenza: più essa è grave, più l'effetto sulla qualità di vita è negativo. Il genere invece ha un impatto poco chiaro, alcuni studi mostrano una leggera influenza generalmente a favore delle donne.

Com'è la situazione nel Canton Ticino?

Una ricerca di dottorato condotta da chi scrive e da poco conclusa si è interessata nello specifico alla qualità di vita delle persone con una disabilità intellettiva che beneficiano di prestazioni socio-educative in diverse strutture (case con e senza occupazione, laboratori, centri diurni e appartamenti protetti) del nostro cantone. I risultati evidenziano che le persone con disabilità intellettiva hanno tendenzialmente un buon livello di qualità di vita. In particolare, i domini del benessere emotivo (soddisfazione, autostima, assenza di stress) e del benessere fisico (stato di salute e stile di vita) sono quelli che hanno

In effetti, gli utenti che beneficiano di prestazioni socio-professionali (che lavorano quindi in un laboratorio protetto) hanno ottenuto dei risultati in termini di qualità di vita più elevati degli utenti che ricevono prestazioni di tipo socio-occupazionale. Inoltre, per gli utenti che vivono in un contesto comunitario è stato riscontrato un livello più alto di qualità di vita rispetto a quelli che vivono in un contesto istituzionale (per esempio una casa con occupazione). Questi risultati non sorprendono, perché sono in linea con le tendenze riscontrate a livello internazionale. Anche alcune variabili personali hanno un'influenza, è il caso in particolare dell'età (più aumenta, minore è la qualità di vita) e del livello di comportamento adattivo, componente fondamentale per definire la gravità della disabilità intellettiva. Più esso è elevato, ovvero più gli utenti sono autonomi, migliore è la loro qualità di vita. Come anticipato, sia le variabili personali che ambientali hanno un influsso sulla qualità di vita, ma è interessante notare che le seconde si sono rivelate più importanti, in quanto hanno mostrato un impatto anche una volta "controllate" le variabili personali.

Come agire per migliorare la qualità di vita?

Il fatto che le variabili ambientali abbiano un peso maggiore rispetto a quelle personali è positivo dal punto di vista socio-educativo, perché implica un certo margine di intervento e controllo, a differenza per esempio dell'età o della gravità della disabilità intellettiva.

I dati indicano come in generale gli sforzi promossi nel nostro cantone per favorire situazioni più inclusive e normalizzanti sono in linea con l'incremento della qualità di vita e potrebbero essere ulteriormente incoraggiati. Parallelamente, occorre essere coscienti che non tutti gli utenti hanno l'autonomia necessaria, per esempio, per lavorare in un laboratorio protetto o nell'economia libera, o per vivere in maniera indipendente. Oltre alle misure applicate a livello macro, sono necessarie anche altre soluzioni che interessano il livello meso (istituzionale) o micro (individuale). Dei miglioramenti sono possibili con i piani di sviluppo o pedaggici individualizzati, che potrebbero essere più indirizzati verso obiettivi legati all'inclusione (essendo uno dei domini che ha ottenuto i risultati meno positivi). Per quanto riguarda i diritti, è possibile seguire dei piani di formazione per favorire il loro esercizio. Questi approcci si sono rivelati efficaci in diversi studi.

IMPEGNO CANTONALE

Strutture d'integrazione sociale e professionale

di Michele Mainardi, professore SUPSI

Lo Stato del Ticino, sulla base della Legge cantonale sull'integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità (LISPI, 1976) e della legislazione federale sulle istituzioni che promuovono l'integrazione (LIPIs, 2006), coordina la realizzazione di strutture

Sappiamo troppo poco della qualità della vita delle persone con disabilità intellettiva e quasi nulla in merito alla loro soddisfazione rispetto alle proprie vite (Edgerton, 1990).

Il paradigma della Qualità di Vita (QdV)

Lo sviluppo della ricerca scientifica, e dei nuovi approcci alla disabilità, a partire da quello bio-psico-sociale introdotto dall'ICF e quello basato sui diritti umani sancito dalla Convenzione ONU sui Diritti delle persone con disabilità riconoscono nella **prospettiva della Qualità di vita** il criterio ispiratore per la revisione e l'innovazione dei servizi forniti alle persone con disabilità, ponendo un'enfasi sulla partecipazione e l'inclusione sociale**.**

(Bollani e altri, 2022)

E per voi?
Cosa determina la vostra Qualità di vita?

Quali sono gli ingredienti indispensabili
per la vostra Qualità di Vita?

Qualche definizione

Il gruppo di lavoro sulla QdV dell'OMS l'ha definita nel 1995 come:

«**La percezione dell'individuo** della propria posizione nella vita nel contesto dei **sistemi** culturali e dei valori di riferimento nei quali è inserito e in relazione ai **propri** obiettivi, aspettative, standard e interessi»

(WHOQOL, The World healt organization quality of life assessment, 1995)

Al di là delle diverse definizioni esistenti, esiste un generale consenso nel considerare **la qualità di vita** un costrutto misurabile con metodi quantitativi e qualitativi e con indicatori di tipo sia generale che soggettivo, **multidimensionale** e **strettamente legato al giudizio personale**.

(Croce, L. Progettare Qualità di vita, Report conclusivo, Anffas, 2015)

A cosa ci serve?

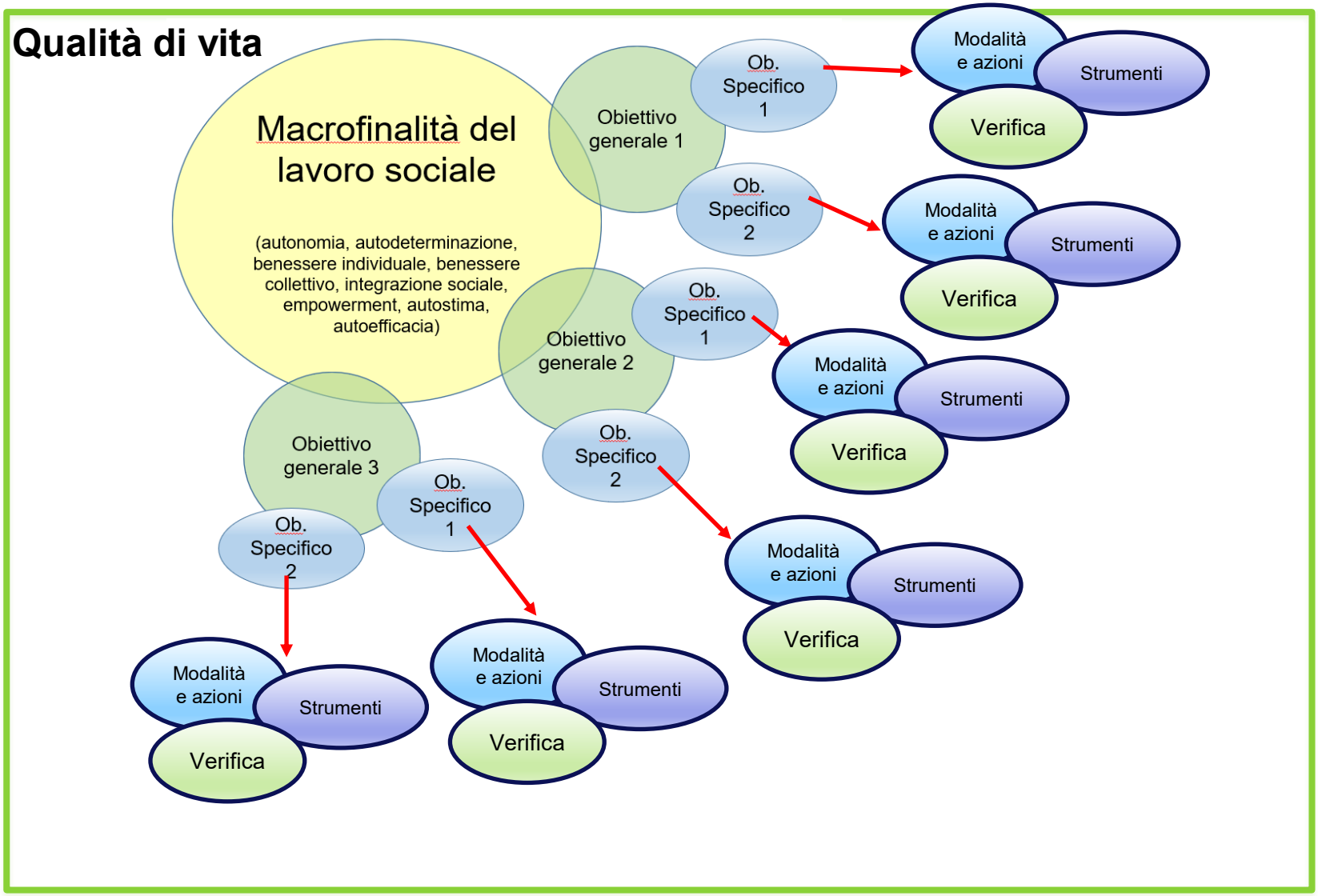
La prospettiva della QdV può diventare al contempo

- sia la macro finalità e l'obiettivo di qualsiasi intervento e **progettazione** educativa

- che il parametro grazie al quale verificare l'efficacia e l'efficienza delle varie azioni messe in campo- **valutazione**

(Cottini, 2016, pag.20)

SUPSI


Qualità di vita
Macrofinalità del lavoro sociale
(autonomia, autodeterminazione, benessere individuale, benessere collettivo, integrazione sociale, empowerment, autostima, autoefficacia)
Obiettivo generale 1
Ob. Specifico 1
Ob. Specifico 2
Obiettivo generale 2
Ob. Specifico 1
Ob. Specifico 2
Obiettivo generale 3
Ob. Specifico 1
Ob. Specifico 2
Modalità e azioni
Strumenti
Verifica
Modalità e azioni
Strumenti
Verifica
Modalità e azioni
Strumenti
Verifica
Modalità e azioni
Strumenti
Verifica
Modalità e azioni
Strumenti
Verifica
Modalità e azioni
Strumenti
Verifica

Il Meta-modello della QdV di Schalock e Verdugo

Il Meta-modello della QdV di Schalock e Verdugo

- È un costrutto **universale** che descrive in maniera articolata i fattori fondamentali che caratterizzano gli obiettivi, i valori e i vissuti di tutte le persone, indipendentemente dalla loro condizione.
- È un **meta-modello** costruito partendo da numerosi modelli provenienti da diverse discipline e in grado di rappresentare la prospettiva della Qualità di vita attraverso l'articolazione di **3 fattori, 8 domini** e una serie di **indicatori**. Evidenzia come:
  - Gli stessi domini di base sono applicabili a tutte le persone
  - La QdV viene migliorata potenziando le persone a partecipare nelle decisioni che riguardano la loro esistenza
  - La QdV viene migliorata dall'accettazione ed inclusione nella comunità
  - La QdV viene migliorata fornendo sostegni
  - La QdV si basa sia su prospettive soggettive che oggettive

I fattori e i domini della Qualità di Vita

QdV FATTORI	QdV DOMINI
INDIPENDENZA	SVILUPPO PERSONALE
	AUTODETERMINAZIONE
PARTECIPAZIONE SOCIALE	RELAZIONI INTERPERSONALI
	INCLUSIONE SOCIALE
	DIRITTI
BENESSERE	BENESSERE EMOZIONALE
	BENESSERE FISICO
	BENESSERE MATERIALE

I fattori, i domini e gli indicatori della QdV

QdV FATTORI	QdV DOMINI	QdV esempi di INDICATORI
INDIPENDENZA	SVILUPPO PERSONALE	Livello di educazione, Abilità personali, comportamento adattivo
	AUTODETERMINAZIONE	Scelte/decisioni, autonomia, controllo personale, obiettivi personali
PARTECIPAZIONE SOCIALE	RELAZIONI INTERPERSONALI	Rete sociale, amicizie, attività sociali, relazioni
	INCLUSIONE SOCIALE	Integrazione/partecipazione nella comunità, ruoli nella comunità
	DIRITTI	Umani (rispetto, dignità, uguaglianza), Legali (assistenza legale, doveri di cittadino)
BENESSERE	BENESSERE EMOZIONALE	Salute e sicurezza, esperienze positive, contenimenti, concetto di sé, mancanza di stress
	BENESSERE FISICO	Stato di salute, stato nutrizionale, esercizio fisico/ricreativo
	BENESSERE MATERIALE	Status finanziario, stato lavorativo, stato abitativo, possessi.

I domini e gli indicatori della Qualità di Vita

Gli Indicatori servono per misurare la qualità della vita,

sono percezioni, comportamenti o condizioni specifici che riflettono il benessere di una persona, sono valutabili attraverso **metodi soggettivi ed oggettivi**.

Un punto importante nella costruzione degli indicatori è la distinzione tra l'aspetto soggettivo (il punto di vista dell'interessato sul singolo aspetto) da quello oggettivo (i dati e le informazioni).

La misurazione oggettiva è basata su quello che è condiviso tra tutti gli essere umani

La misurazione soggettiva è basata sulle preferenze, le esperienze e i vissuti personali

Esempi di indicatori

Fattore Indipendenza

Nel dominio dell'**autodeterminazione** si intende misurare la capacità e la soddisfazione di fare delle scelte, di esprimere, ciascuno secondo le proprie capacità e mezzi comunicativi, le proprie preferenze, di usufruire delle opportunità che l'ambiente offre in base ai propri desideri ed alle proprie intenzionalità;

nel dominio dello **sviluppo personale** si riferisce alla soddisfazione e capacità di conquistare la propria autonomia in tutti i contesti e per l'intero arco di vita;

Fattore Partecipazione sociale

Il dominio delle **relazioni interpersonali** si riferisce alla possibilità di godere dei contatti e dello scambio con i familiari, gli amici, le persone che si conoscono. Le Relazioni interpersonali soddisfacenti e di qualità sono quelle con persone che ci comprendono, con cui passiamo volentieri il nostro tempo e con le quali condividiamo con piacere qualcosa.

L'ambito dell'**inclusione sociale** si riferisce alla possibilità di sentirsi parte di un gruppo e di una comunità, di non sentirsi esclusi o in altre parole di frequentare con soddisfazione il proprio ambiente di vita utilizzando in modo pieno le risorse e le possibilità che questo offre;

per qualità della vita nell'ambito dei **diritti** si intende infine la garanzia ed i benefici della tutela e della protezione attiva di cui ciascuno gode in quanto essere umano, grazie all'esistenza ed al rispetto di norme e leggi adeguate.

Esempi di indicatori

Dominio benessere

Per qualità della vita nell'area del **benessere fisico** si intende la condizione di buona salute di cui ciascuno gode, grazie ad una buona alimentazione e ad uno stile di vita sano, alle cure che riceve, alla possibilità di controllare il dolore e lo stress ed alla possibilità di riposarsi e rilassarsi adeguatamente;

nell'ambito del **benessere emozionale** questa si riferisce alla possibilità di sentirsi soddisfatti di se stessi e della propria vita, di apprezzare come positivo il proprio stato d'animo, di percepire un assetto gradevole del proprio rapporto con se stessi e con il mondo.

Per **benessere materiale** si intende la possibilità di disporre di risorse materiali, denaro, di propri effetti personali, abiti, oggetti, di un proprio posto in casa. Godiamo di un buon benessere materiale quando la nostra vita non scorre in condizioni di povertà.

Gli 8 domini declinati in parte dell'*ecosistema*

1. *Microsistema* → attinente la crescita personale e le opportunità di sviluppo
2. *Mesosistema* → i programmi, le progettazioni dei sostegni, ambiente e servizi, comunità
3. *Macrosistema* → relativo alle politiche sociali

Nei tre sistemi sopracitati gli indicatori di QdV possono svilupparsi in modo diverso, talvolta antitetico, ovvero i tre sistemi possono essere disallineati e questo può creare disfunzionalità influenzando la QdV di una persona.

(Cottini, 2016, p.21)

Progettare Qualità di Vita: il Progetto di vita

In un'ottica dei percorsi di vita delle persone, unici e irripetibili, dove ognuno continua ad apprendere dalle esperienze con cui si confronta ed è corresponsabile delle proprie traiettorie di crescita, il progetto socioeducativo esce da una dimensione tecnica professionale per sovrapporsi alla **progettualità di vita** della persona.

In questa accezione i nuovi approcci dialogico partecipati si spostano dal concetto di Progetto di sviluppo individuale (PSI) o Progetto educativo individualizzato (PEI) che propongono ancora una logica in cui é il professionista che ha in mano il progetto al concetto di **Progetto di vita.**

Il Progetto di vita traduce la **dimensione progettuale e di senso** della propria vita, fondamentale per il proprio benessere e la **propria qualità di vita**.

Per co-costruire un Progetto di vita è necessario prefigurare, **immaginare il proprio futuro,** tenendo conto di **potenzialità, talenti, desideri e aspirazioni** che devono essere trasformati in aspettative realistiche e tradotti con progettualità mirate nel breve, medio e lungo termine, considerando i diversi ruoli sociali che ogni persona si trova e si troverà ad assumere. (Dispensa TMIS 2025)

Progettare Qualità di Vita: il Progetto di vita

Nella prospettiva della Qualità di Vita, co-costruire Progetti di vita significa:

- prendere in considerazione tutte le variabili individuali ed ambientali che concorrono alla qualità di vita della persona nel rispetto dei suoi diritti umani;
- porre attenzione ad individuare e a risolvere ostacoli, barriere e discriminazioni,
- programmare, insieme alla persona e alla famiglia gli obiettivi e i sostegni necessari partendo dai suoi desideri e aspettative,
- monitorare e valutare gli esiti personali in termini di Qualità di Vita

La valutazione iniziale o assessment

La valutazione iniziale è un processo di conoscenza ed analisi della situazione problema su cui s'intende intervenire, della domanda, di potenzialità e limiti, dei bisogni e delle situazioni di disagio.
(Dispensa TMIS)

Lo scopo della valutazione iniziale è conoscere i desideri e confrontarli con la situazione attuale della persona per iniziare a disegnare il cambiamento che vogliamo raggiungere. Per pianificare e progettare sistemi di sostegno

Secondo l'approccio della QdV la pianificazione degli interventi deve basarsi innanzitutto sul punto di vista delle persone, sui loro interessi e priorità.

(Turati, M. e Pozzi, M., 2024)

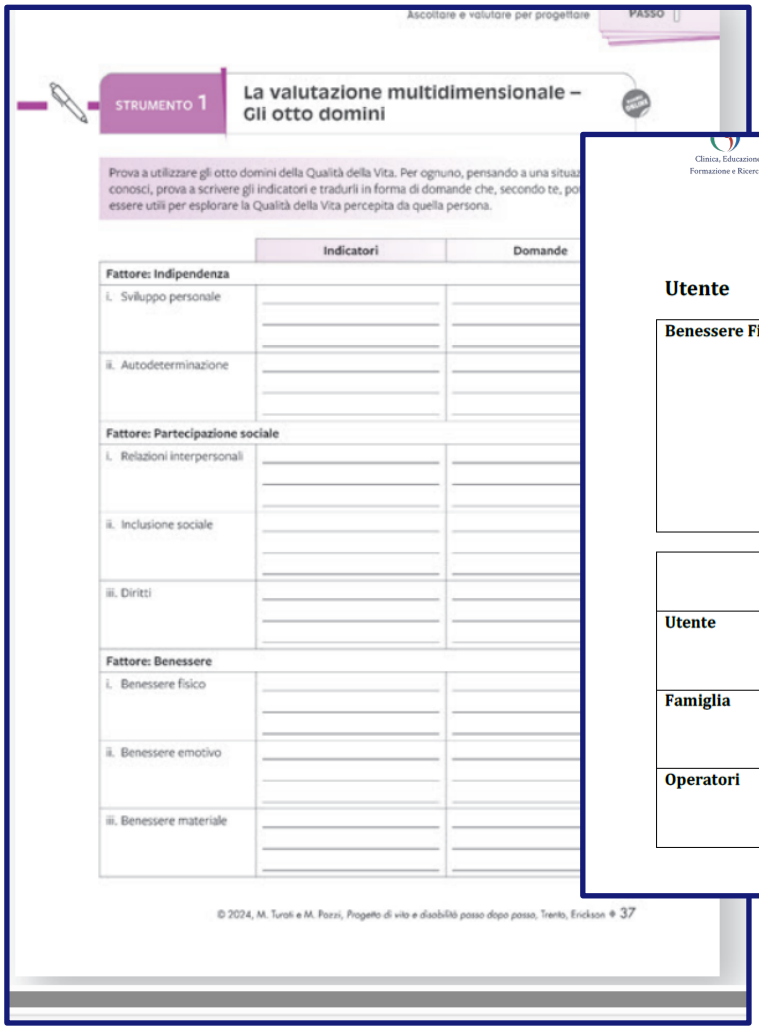
Entriamo nella progettazione: la valutazione iniziale

Per scrivere un buon progetto di vita è importante ascoltare la persona con disabilità, la sua famiglia e tutte le persone che hanno delle informazioni importanti sulla persona.

Si fa riferimento all'espressione **valutazione multidimensionale** per indicare la necessità di adottare uno sguardo ecologico alla condizione di disabilità, che tenga in considerazione le caratteristiche individuali così come le caratteristiche del contesto di vita della persona, in riferimento all'ICF- approccio biopsicosociale.

(Turati, M. e Pozzi, M., 2024)

Entriamo nella progettazione: strumenti di valutazione



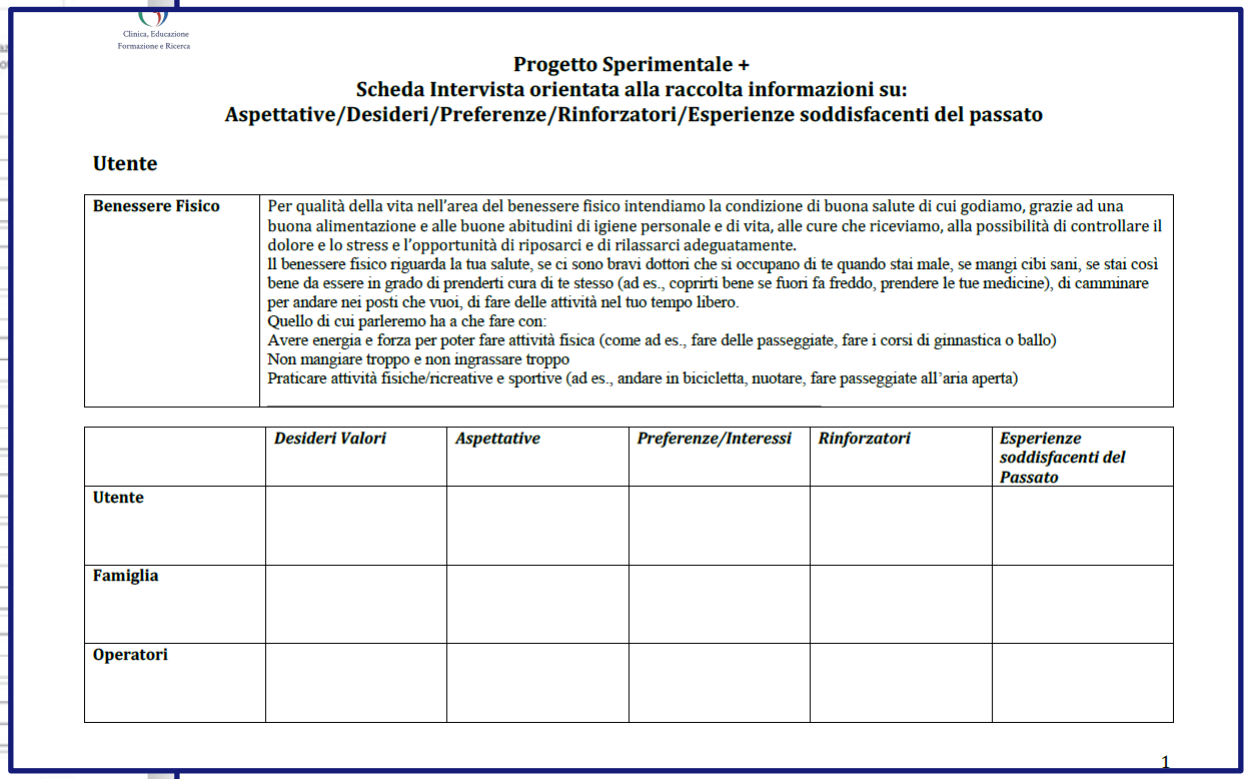
Ascoltare e valutare per progettare PASSO

STRUMENTO 1 **La valutazione multidimensionale – Gli otto domini**

Prova a utilizzare gli otto domini della Qualità della Vita. Per ognuno, pensando a una situaz conosci, prova a scrivere gli indicatori e tradurli in forma di domande che, secondo te, po essere utili per esplorare la Qualità della Vita percepita da quella persona.

	Indicatori	Domande
Fattore: Indipendenza		
i. Sviluppo personale		
ii. Autodeterminazione		
Fattore: Partecipazione sociale		
i. Relazioni interpersonali		
ii. Inclusione sociale		
iii. Diritti		
Fattore: Benessere		
i. Benessere fisico		
ii. Benessere emotivo		
iii. Benessere materiale		

© 2024, M. Turoli e M. Pozzi, *Progetto di vita e disabilità passo dopo passo*, Trento, Erickson ♦ 37



Clinica, Educazione Formazione e Ricerca

Progetto Sperimentale +
Scheda Intervista orientata alla raccolta informazioni su:
Aspettative/Desideri/Preferenze/Rinforzatori/Esperienze soddisfacenti del passato

Utente

Benessere Fisico	Per qualità della vita nell'area del benessere fisico intendiamo la condizione di buona salute di cui godiamo, grazie ad una buona alimentazione e alle buone abitudini di igiene personale e di vita, alle cure che riceviamo, alla possibilità di controllare il dolore e lo stress e l'opportunità di riposarci e di rilassarci adeguatamente. Il benessere fisico riguarda la tua salute, se ci sono bravi dottori che si occupano di te quando stai male, se mangi cibi sani, se stai così bene da essere in grado di prenderti cura di te stesso (ad es., coprirti bene se fuori fa freddo, prendere le tue medicine), di camminare per andare nei posti che vuoi, di fare delle attività nel tuo tempo libero. Quello di cui parleremo ha a che fare con: Avere energia e forza per poter fare attività fisica (come ad es., fare delle passeggiate, fare i corsi di ginnastica o ballo) Non mangiare troppo e non ingrassare troppo Praticare attività fisiche/ricreative e sportive (ad es., andare in bicicletta, nuotare, fare passeggiate all'aria aperta)

	Desideri Valori	***Aspettative***	***Preferenze/Interessi***	***Rinforzatori***	***Esperienze soddisfacenti del Passato***
Utente					
Famiglia					
Operatori					

1

I PEI/PSI sono tasselli del progetto di Vita

Esistono diversi modelli ed applicazioni, oggi principalmente ispirati all'ICF, cioè al modello bio-psico-sociale e che integrano l'approccio della Qualità di Vita e vengono co-costruiti in maniera partecipata e dialogica.

Ogni Istituzione ha un suo modello piu' o meno articolato e differenziato, in questi ultimi anni i modelli vengono aggiornati in base all'evoluzione degli approcci e oggi come abbiamo visto fanno riferimento al **paradigma della Qualità di Vita**.

È fondamentale per svolgere un'azione educativa **sensata**, **mirata** e **condivisa.**

«*…i progetti individuali nascono e si riconducono al progetto di vita…significa avere in mente che gli obiettivi che si perseguono negli specifici contesti di intervento a scuola o durante l'attività del servizio diurno, sono coerenti con la finalità e gli obiettivi del progetto di vita della persona (…) non dovremmo quindi trovare obiettivi (a cui conseguono azioni) contraddittori (…)»*

(Turati, M. e Pozzi, M., 2024)

I PEI/PSI sono tasselli del Progetto di Vita

Caratteristiche del Progetto di sviluppo individualizzato:

- Ha come obiettivo finale il Progetto di Vita di una persona, comprende l'acquisizione e lo sviluppo di abilità sociali, dell'autonomia e di autodeterminazione
- Costituisce il documento di sintesi dei dati conosciuti e di previsione degli interventi individualizzati prospettati
- Esplicita gli obiettivi, le attività didattiche/ educative e gli atteggiamenti educativi "su misura"
- Dichiara i progetti didattico-educativi, abilitativi e di socializzazione individualizzati
- È integrato dal piano della settimana con atelier, scuola, terapie, intervento individuale, attività extra Istituto.

I PEI/PSI sono tasselli del Progetto di Vita

Ogni Istituzione utilizza un proprio modello,

più o meno articolato e differenziato che rispecchia la sua cultura e i suoi utenti.

Nei PSI costruiti secondo il modello ICF, le aree di valutazione, cioè di raccolta dei dati sono:

- funzioni corporee;
- strutture corporee;
- attività personali;
- partecipazione sociale;
- fattori contestuali ambientali;
- fattori contestuali personali.

PEI/PSI sono tasselli del Progetto di Vita

In generale:

- Dichiara gli obiettivi efficaci per la singola e specifica persona, valutando limiti ma anche risorse e punti di forza sui quali pianficare il lavoro e gli interventi.
- Tiene in considerazione anche le risorse dell'ambiente
- È stabilito in base a scelte condivise in equipe, con l'utente e con la rete e ne costituisce un tessuto di collaborazione
- Tiene in considerazione i desideri, le motivazioni, i piaceri e le passioni di ogni utente
- Mette in relazione le caratteristiche del soggetto e del contesto

Progettare Qualità di vita, progettare Vite di qualità

- (…) nell'intessere una relazione educativa con un singolo soggetto occorre muovere dalla chiara consapevolezza che il benessere personale perseguito è complesso, articolato, dinamico. La comunicazione educativa avviata fa insorgere processi di chiara natura sistemica i quali, contro qualsiasi inclinazione dell'educatore a circoscrivere il proprio intervento ad un settoriale aspetto dell'esistenza dell'educando, gli richiedono la capacità di **correlare il particolare con l'universale, la parte con il tutto.** (…)

  Il costrutto QdV sta provocando un processo di radicale trasformazione nei servizi professionali di aiuto alla persona. A questi, infatti, sempre più frequentemente si chiede di modificare la logica di funzionamento: da una impostazione tesa a privilegiare il più o meno passivo adeguamento del "cliente-utente" al servizio e alle terapie erogate, ad una **continua riformulazione** dell'intervento erogato, per meglio **soddisfare i bisogni della persona**. In questa luce, la "qualità dei servizi" è misurata non più soltanto in forza del numero di trattamenti garantiti bensì anche e soprattutto **in riferimento alla qualità di vita delle persone che ne usufruiscono** (…)

- (Croce, L. Progettare Qualità di vita, Report conclusivo, Anffas, 2015, pag.8 e 9)

Bibliografia specifica

- Bollani M. et al, *Disabilità e vita indipendente? Si può fare*!, Ed. La Scuola, Brescia, 2022
- Cottini, L., L'autodeterminazione nelle persone con disbailità. Erickson, Trento, 2016
- Croce, L., *Progettare Qualità di vita*, Report conclusivo, Anffas, 2015
- Lepri C., *Diventare grandi, la condizione adulta delle persone con disabilità intellettiva*, Erickson Trento, 2020
- Murphy R.F., *Il silenzio del corpo*, Erickson, Trento, 2017
- Schalock R. e Verdugo M., *Manuale della Qualità di vita*, Vannini Ed., Brescia, 2006
- Turati M. e Pozzi M., *Progetto di vita e disabilità*, Erickson, Trento, 2024